Diskussion 1772

Datum: 1928-04-21
Kammare: Andra kammaren
Antal yttranden: 5
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus, byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).
Projekt: https://github.com/DigitalHistory-Lund/ToK-Preparer
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18211787
Version: 2026.10.14

Markerade ord: ¹ kvinna-ord, ² släktskaps- och tilltalsord, ³ yrkestitlar.

1. Per Nilsson (Lantmanna- och borgarepartiet inom andrakammaren, man)

Herr talman! Under den förevarande punkten har i motion hemställts »att riksdagen ville i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa, att Kungl. Maj:t måtte skyndsammast låta utreda, huruvida

och efter vilka grunder bidrag av statsmedel må kunna utgå till de kommuner och skoldistikt på landsbygden, och i vissa fall även till stadskommuner, som införa regelbundna läkarundersökningar vid folkoch småskolorna».

Vid handläggningen jav detta ärende har statsutskottet delat sig på två linjer. Så till vida råder emellertid full enighet att alla anse, att spörsmålet är förtjänt av ett allvarligt övervägande. Detta säges såväl i utskottets utlåtande som i reservationen. Reservanterna yttra nämligen: »Utskottet vill ingalunda underskatta betydelsen av den fråga, som i förevarande motion beröres; tvärtom är densamma enligt utskottets mening värd all uppmärksamhet.> För min personliga del är jag fullkomligt övertygad om vikten och betydelsen av åtgärder i avsikt att förekomma sjukdom, och ju tidigare dessa förebyggande åtgärder kunna vidtagas, desto verksammare äro de otvivelaktigt. Jag har styrkts i denna uppfattning genom iakttagelser under mitt arbete såsom fullmäktig i pensionsstyrelsen, där man har sysslat rätt mycket med denna sak och därvid ernått ett gott resultat med avseende å förebyggande åtgärder. När därför **fru²** Nordgren, som kommer att tala näst efter mig, får ordet, behöver **fru²** Nordgren ingalunda besvära sig med att övertyga oss om, att det är en beaktansvärd sak att införa regelbundna läkarundersökningar vid folkoch småskolor. Därom äro vi alla övertygade. Jag tror ej, att det möter protest från något håll. Jag är personligen livligt övertygad om, att det kunde vara önskvärt.

Men saken har också en annan sida, nämligen den ekonomiska. Och skulle **fru²** Nordgren kunna övertyga oss därom, att saken låter sig genomföras utan alltför stora uppoffringar från det allmännas sida, kunna :vi möjligen finna anledning att frånfalla våra betänkligheter. ICKostnaderna måste med nödvändighet bliva avsevärda. Hur stora veta vi i närvarande stund icke. Väl är det sant, att här begäres endast en utredning om saken. Och en utredning om, huruvida det låter sig genomföras och på vad sätt, skulle man naturligtvis kunna gå in för.

Men det är uppenbart, att i och med att man gör detta, har man på samma gång gjort en utfästelse att saken också skall effektueras.

Nu säger man, att för eleverna vid de allmänna läroverken har denna förmån varit beredd sedan trettio år tillbaka. Det är sant. Det har givetvis lättare kunnat göras, därför att dessa elever utgöra ett ganska begränsat antal och äro samlade på färre ställen och ej såsom folkoch småskolans lärjungar spridda i landets olika delar. Svårigheterna och kostnaderna ökas naturligtvis högst betydligt, då det gäller att utsträcka verksamheten över hela vårt långa och vidsträckta land från Ystad till Haparanda. Och kostnaderna ökas väsentligt genom de reseersättningar, som det allmänna måste vidkännas för läkarna i detta fall.

Det är icke nog med, att man får konstaterat, att den ena och den andra eleven är behäftad med den och den skavanken. Skall något verkligt resultat uppnås, måste medel ställas till förfogande för att bota de eventuella åkommorna.

Inför alla dessa omständigheter ha vi reservanter verkligen tvekat, huruvida vi skulle våga ge oss in för en utredning, som i perspektivet har detta vidsträckta ekonomiska problem och dessa kostnader, vars räckvidd vi omögJligen kunna överblicka. Man har tidigare här i dag påtalat de automatiska kostnadsökningar, som på många punkter förekomma och ej minst under åttonde huvudtiteln. Nu är man emellertid på väg att gå in för en utredning, som givetvis, därest den skall leda till resultat, kommer att medföra kostnader, till en början små, men som sedermera undan för undan otvivelaktigt komma att växa med lavinartad hastighet. Och man vet ej, vad slutet blir. Det är inför automatiska kostnadsökningar av detta slag, som vi ha hesiterat,

och, som sagt, ej för själva saken, ty den finna vi vara värd beaktande. Läget för närvarande är sådant, att man ej bör binda sig vid en utredning, som kan leda till utgiftsökningar av nu icke överskådlig räckvidd.

2. Olivia Nordgren (Socialdemokraterna, woman)

Herr talman, mina herrar! Reservanterna ha i sin reservation erkänt det behjärtansvärda i denna fråga och sagt, att den är värd all uppmärksamhet, och herr andre vice talmannen har i sitt anförande ytterligare understrukit detta. Men oaktat detta erkännande har man från reservanternas sida icke ansett sig kunna gå med på några åtgärders vidtagande för att få en lösning av densamma för landsbygdens vidkommande.

Ett av de skäl, som anföras mot motionen, är att enbart läkarundersökningar av skolbarnen icke skulle föra till det åsyftade målet, utan att härför tarvas mera effektiva åtgärder såsom en målmedvetet bedriven propaganda och upplysningsverksamhet. Om de ärade reservanterna något noggrannare genomläst motionen, skulle de ha funnit, att det föreslagna ekonomiska stödet från statens sida till landsbygdens folkskolor jämväl avser att förhjälpa till spridande av en dylik upplysningsverksamhet och hygienisk propaganda, i förening med ett övervakande av barnens hälsotillstånd. Den, som läser sista stycket på sidan 122 i

utskottsbetänkandet, där motionen återfinnes, måste nämligen finna, att just denna upplysningsverksamhet är det centrala i vad som här åsyftas. Här omnämnes det system, som införts vid ett flertal av landets folkskolor, främst städernas, genom initiativ av vårt lands främste och banbrytande skolhygieniker, doktor Ljunggren i Trälleborg, vars arbete säkerligen i en framtid kommer att ha en oerhört stor betydelse för folkhälsans förbättrande. På sidan 24 i betänkandet understrykes detta ytterligare, då det säges: »Som villkor för statsbidrags erhållande torde också uppställas vissa krav på undersökningarnas beskaffenhet, såsom upprättande av hälsoregister o. s. v. samt redogörelse för verksamheten under den tid, för vilken bidrag utgått.» Av detta torde tydligt framgå, att jag i min motion inte avser ett införande av slentrianmässiga läkarundersökningar, som äro till föga eller intet gagn, utan till införande av väl ordnade och effektiva sådana, vilket kan ske genom samverkan mellan lärare och läkare å ena sidan samt barnen och barnens föräldrar å andra sidan.

Ett annat skäl som förebäres från reservanternas sida — och jag tror att det av herr andre vice talmannen anfördes såsom varande det starkaste skälet — var de ekonomiska konsekvenser, ett bifall till motionen skulle kunna medföra för staten. Det framhålles också, att denna fråga främst synes vara en kommunernas angelägenhet. Till detta vill jag anföra, att jag 1 min motion adrig ifrågasatt annat, än att det främst skulle bli en kommunernas angelägenhet att ordna denna sak, och att endast ett visst ekonomiskt stöd från statsmakternas sida skulle påkallas. Jag begär icke i min motion, att dylik verksamhet skall åläggas kommunerna från statens sida utan endast att de kommuner, som själva insett betydelsen av en sådan verksamhet och infört den vid sina skolor, skola kunna räkna på statens stöd för denna samhällsgagnande och i bästa mening nationella angelägenhet. Jag tror icke heller, att kostnaderna skola bli så förfärligt avskräckände utan att dessa mycket väl kunna hållas inom en skälig ram. Om vi till en början skulle tänka oss ett statsanslag motsvarande det belopp per år, som för sagda ändamål för närvarande utgår till allmänna läroverken, och som i dag tidigare på dagordningen för budgetåret 1928—1929 fastställts till att utgå med 92,450 kronor, tror jag säkerligen, att vi skulle hinna ett gott stycke på vägen för att hjälpa landsbygdens kommuner enbart med ett sådant anslag. Vi skulle för övrigt ha råd att höja det anslaget åtskilliga kronor per år och likväl skulle det dröja ganska länge, innan vi komma upp till de summor, som utgått till läkarvården

för läroverkens barn under de 35 år, som dylik skolläkarvård varit ordnad vid dessa skolor.

Nu frågar man sig: med vad större rätt kräves, att skattemedel skola utgå för vården om hälsotillståndet för läroverkens barn än för folkskolans eller landsbygdens barn? Äro de icke landets barn både de, som gå i folkskolan, och de, som gå 1 läroverken? Är icke deras hälsa från landets synpunkt lika betydelsefull?

Det sades här av herr andre vice talmannen, att det vore lättare att för sådant ändamål ge detta anslag till läroverken, därför att dessa icke voro så många och låge icke så spridda, och det har tidigare sagts från annat håll, att skolläkarevården lättare kunde ordnas vid

läroverken, därför att dessa vore statens egna skolor. Jag anser icke något av dessa skäl vara avgörande. Staten har så stort och betydande inflytande över och så stora kostnader för folkskolan, att det bör vara av lika stor vikt, att folkskolebarnens hälsotillstånd övervakas och barnen vårdas, så att de kunna tillgodogöra sig den undervisning, som påkostas dem, som det är beträffande de högre skolornas barn. Härtill kommer ett annat skäl, och det är, att när det gäller läroverkens elever, så är det väl ändå så mina herrar, att deras föräldrar i allmänhet ha betydligt större ekonomiska möjligheter att sörja för sina barns läkarundersökning och läkarvård i övrigt, än vad fattiga föräldrar kunna göra. Det framgår också av den undersökning, som i olika länder företagits angående barnens tillstånd vid de olika skolorna, att det icke är så av behovet påkallat med läkarvården i dessa högre skolor, därtör att, såsom denna undersökning visar, de högre läroverkens barn i allmänhet äro betydligt mera utvecklade än folkskolans barn. Doktor Schiötz 1 Norge har företagit undersökningar och jämförelser mellan barn ur de olika skolorna och av dessa framgår att 11 års pojkar i folkskolan ha en medellängd av 135 cm. och en vikt av 30 kg., medan samma längd och vikt i regel förefinnas hos en 9 ?/; år gammal gosse vid ett högre läroverk. Och det är liknande för alla åldrar. Detta utvisar tydligt och klart, att när det gäller barn ifrån de väl!situerade hemmen — det största antalet av läroverkens lärjungar — ha dessa en bättre ställning redan från begynnelsen, därför att deras hem ha bättre hygieniska förhållanden och näringsproblemet är bättre ordnat för dessa barn än för barn från fattiga hem.

De kommunala myndigheterna, framför allt i städerna, ha också haft en erkännansvärd förståelse för betydelsen av en hälsovårdande verksamhet vid folkskolorna. Och det är särskilt en kår, som är värd en honnör för sitt stora intresse för denna fråga, nämligen Sveriges folkskollärarekår. Jag vill i detta sammanhang påpeka ett tryckfel, som insmugit sig 1 motionen och som 1 viss mån är a I första stycket på sidan 122 i utskottsbetänkandet, där motionen återgives, står nämligen: »Beträffande folkskolornas barn har man däremot, som nämnts, helt överlämnat omvårdnaden av dessa åt kommunerna och det enskilda initiativet. Detta ehuru krav på en ordnad skolläkareverksamhet upprepade gånger framförts från läkarkårens sida ete.» Det skall vara lärarkårens. Vilket är en väsentlig skillnad, ty ifall man vill vara illvillig, skulle man ju kunna tillskriva läkarnas intresse andra motiv än barnens bästa. Men det kan icke ske när det gäller lärarna, fastän det är ju givet. att det är bättre för lärarkåren att arbeta med ett friskt barnmaterial än med ett sjukligt och klent sådant. Det har, som sagt, också visat sig, att städerna 1 stor utsträckning ordnat skolläkarverksamheten vid folkskolorna. Av en utredning, som Svenska stadsförbundet välvilligt ombesörjt på min begäran, framgår detta med önskvärd tydlighet. Av 75 tillfrågade städer ha svar ingått från 73. Och av dessa 73 ha 65 anordnat regelbundna läkarundersökningar, och undersökningarnas antal under elevernas hela skoltid variera mellan en gång och upp till 14 gånger, varvid dock vid flertalet skolor antalet under-

sökningar uppgå till 2 å 3 gånger under skoltiden. Vid samtliga skolor, med undantag för 6, föres hälsoregister över barnen, vid flertalet över samtliga barn, men i vissa fall endast över de klena och sjuka barnen. I ett 40-tal skolor erhålla medellösa, sjukliga barn helt eller delvis

fri läkarvård och medicin samt specialvård antingen på skolans eller fattigvårdens bekostnad. Kostnaderna för denna verksamhet variera mellan 3,500 till 100 kronor per år och detta visar ju, att dessa inte äro så betydande som herr andre vice talmannen förmodade de skulle komma att bli. Givetvis äro kostnadernas storlek beroende på barnantalets storlek och arten av de företagna åtgärderna. Utredningen omfattar endast små och medelstora städer.

Vid en hänvändelse i samma syfte till svenska landskommunernas förbund blev svaret avvisande, men i detsamma heter det: »På landsbygden äro läkarundersökningar av skolbarn mindre vanligt.» Just detta svar bekräftar nödvändigheten av att något göres för att sprida denna nyttiga verksamhet även till landsbygden.

Det klagas ofta här i kammaren, vid behandling av skilda frågor, över att landsbygder får stå tillbaka i många avseenden gent emot stadsbefolkningen. Här är ett tillfälle att hjälpa landsbygden, som jag hoppas landsbygdens representanter skola beakta. Att läkarvård är behövlig jämväl för landsbygdens skolbarn framgår av resultatet av en undersökning, som av doktor Ljunggren företagits vid 12 folkskolor på landsbygden i Malmöhus län. Denna undersökning utvisar, att av samtliga undersökta 667 barn, voro icke mindre än 128 stycken eller 19.2 Z, tuberkulösa. Av samma barnantal befanns 346 stycken eller 51.9 Z ha kroniskt inflammerade halskörtlar, vilket i många fall också kan betyda tuberkulos, 375 stycken eller 56.2 4 voro behäftade med rygghållningsoch skelettfel, och därtill kommer ett antal av 125 eller 18.2 4, som voro bleka och anemiska. Ännu mera framträdande bli förhållandena om man tar en enskild skola i detta län, en skola på rena landsbygden, där det icke finns någon annan industri än en sockerfabrik. Vid en undersökning omfattande 45 barn i denna skola visade det sig, att icke mindre än 10 eller 22.3 £ voro behäftade med tuberkulos, medan 35 eller 69 Z hade ryggradseller andra deformiteter och 25 eller 55.5 24 kroniskt inflammerade halskörtlar. Av detta barnantal på 45 stycken hade vidare icke mindre än 5 stycken äggvitesjukdom. Detta visar ju klart och tydligt, att sjukligheten bland landsbygdens barn är ganska stor, och att det är nödvändigt, att det även för landsbygdens vidkommande göres något för att avhjälpa detta.

Samme läkare har också genom erhållet anslag ur den Andersonska fonden företagit undersökningar, som omfatta icke mindre än 40,000 folkskolebarn i vårt land. Jag har tagit del av en översikt över dessa undersökningar — vilken finnes tillgänglig här för dem, som äro intresserade av densamma -—— och som upptager såväl landsbygdsskolornas barn som stadsskolornas barn. Av denna översikt framgår med önskvärd tydlighet, att antalet klena barn är ganska stort. De ha av en annan läkare, doktor Nylin i Spånga, som också ägnat sitt speciella intresse åt denna sak, uppskattats till omkring 20 å 30 4 av samtliga barn här i landet. Detta pekar på nödvändigheten av att staten ägnar denna fråga nödig uppmärksamhet och lämnar sitt stöd åt dess lösning både ekonomiskt och på annat sätt. Framför allt bör man på det håll här i riksdagen, där man hyser farhågor för nationens framtid, på grund av den starkt sjunkande nativiteten, ge denna sak sitt stöd och inte ställa sig avvisande, ty om kvantiteten minskas är det av största vikt att kvaliteten höjes. .

Det ägnas ganska stor omsorg åt och stora ekonomiska kostnader för kreaturens rasförädling och förbättring. Man väger och mäter ut maten med minutiös noggrannhet och omsorg åt djuren och omhuldar deras välbefinnande på alla sätt. Ja, jag läste till och med här om dagen någonstans i en tidning,

att man vid en lantbruksskola i Norge inköpt en högsolsapparat och inmonterat den i anstaltens svinhus. Detta skulle framför allt göra spädgrisarna hvligare och minska dödligheten. Huru skulle det vara, om man började bli lika omtänksam om små fattiga människobarn? Skulle de inte kunna anses lika värdefulla som spädgrisar?

Till sist vill jag framhålla, att jag i förevarande fråga vet mig föra **mödrarnas²** talan och **mödr arnas²** krav. Det finns inga meningsskiljaktigheter i denna fråga mellan **kvinnorna¹** ur olika samhällsklasser. Arbetarkvinnorna ha flerfaldiga gånger å möten och konferenser framfört kraven på läkareundersökningar och läkarevård jämväl för folkskolornas barn och svenska husmoderföreningens riksförbund begärde för ett par år sedan i skrivelse till regeringen att läkarevård skulle beredas åt landsbygdens skolbarn. Jag hoppas också, att riksdagen i år skall besluta taga första steget till denna frågas lösning, och jag kan tillägga, att om så sker vore det icke en dag för tidigt. Herr talman, jag ber att i anslutning till vad jag här anfört. få yrka bifall till utskottets hemställan.

3. Bertha Wellin (–, woman)

Herr talman! Jag förstår fullt väl och senterar även de ekonomiska betänkligheter, som ligga till grund för reservationen och som också framförts av herr andre vice talmannen. I detta sammanhang kan man ävenså diskutera om, huruvida de kostnader, som medfölja en sådan åtgärd, skola läggas på kommunen och staten eller kommunen och landstinget eller på alla tre. Det kan ju läggas olika synpunkter på denna fråga. Emellertid ligger saken nu så till, att inom hela den civiliserade världen gå ansträngningarna att förbättra folkhälsan i den riktningen, att man lägger an på verkliga och effektiva förbättringar på hygienens och det förebyggande arbetets område. På grund härav kan jag icke ansluta mig till reservationen utan ställer mig på utskottslinjen. Man har, som sagt, diskuterat olika förslag i detta sammanhang och även sagt, att det kommer att medföra väsentliga kostnader, men jag tror, att det blir kostnader, som i en framtid komma att förränta sig och kanske betala sig med ränta på ränta i en förbättrad folkhälsa. Det är, som sagt, på den grund, herr talman, som jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

4. Adolf Wallerius (–, man)

Herr talman! Den erfarenhet, som jag sedan ett 10-tal år har av dessa läkarundersökningar i det skoldistrikt, som jag tillhör, vilka företagits inom första och femte klasserna och ha omfattat fullständiga undersökningar, vägning och inregistrering efter kortsystem, visar i den riktningen, att jag skulle vilja tillstyrka vad statsutskottet föreslagit. Denna min erfarenhet kan sammanfattas, tror jag, däri, att det i tid blir upptäckt, vad som fattas barnen i fysiskt avseende, och att därigenom möjliggöres det andra, som är minst lika viktigt, att de bli

föremål för den omvårdnad och den behandling, som motsvarar deras behov. Jag tror emellertid, att det är fullt riktigt, vad: herr andre vice talmannen sade, då han hänvisade på behövligheten av att det verkligen blir en sådan behandling och en sådan omvårdnad. Jag vill också omnämna den erfarenhet jag för min del har av, om icke nödvändigheten, så ändå det stora gagnet av att det finns en kommunalt anställd **sjuksköterska**[3] eller församlingssyster, om icke precis i den kommunen så ändå nära till hands icke blott för att kunna vara läkaren till hjälp vid undersökningar, till vilka han många gånger har knappare tid, än han ursprungligen beräknade, i det han får många besök just den dagen; men framför allt behöver **hon**[2] gå hem-

men och föräldrarna till handa med avseende på omvårdnaden och behandlingen av barnen, då ju företagsamheten i detta avseende av olika anledningar icke är så stor på landsbygden.

Jag har icke nämnt detta för att ställa upp några ytterligare villkor eller lägga några stenar i vägen för förslaget, ty min erfarenhet går 1 den riktningen, att denna sak behöver uppmuntras från statens sida.

Jag ber i anledning av detta, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

5. Sven Bengtsson (Folkpartiet, man)

Herr talman! Motionären sade nyss, att det var icke en dag för tidigt, att första steget togs på denna väg. Jag vill emellertid erinra om, att det är länge sedan, riksdagen tog första steget. Redan år 1913 beslöt nämligen riksdagen en skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran om en utredning. Denna utredning överlämnades den 30 september 1916 av folkskoleöverstyrelsen till Kungl. Maj:t, och det hade infordrats yttranden såväl från medicinalstyrelsen som domkapitlen och folkskoleinspektörerna. Folkskoleöverstyrelsen begärde för ifrågavarande ändamål ett anslag på 100,000 kronor. Ärendet föredrogs för Kungl. Maj:t år 1922, då herr Olof Olsson satt som ecklesiastikminister, men Kungl. Maj:t beslöt, att med hänsyn till å ena sidan de stora kostnader, som enligt den i ärendet verkställda utredningen detta statsbidrag skulle åsamka statsverket, och å andra sidan det rådande statsfinansiella läget, fann Kungl. Maj:t riksdagens berörda skrivelse icke föranleda någon Kungl. Maj:ts vidare åtgärd. Ärendet har alltså prövats av Kungl. Maj:t så sent som år 1922 men då icke ansetts böra framläggas för riksdagen, och detta har varit anledningen till att jag såväl på avdelningen som i utskottet både talat och röstat emot den föreliggande motionen, ehuru jag liksom de föregående talarna erkänner, att det är av stor betydelse, att våra barn få den bästa behandling och genom läkarundersökningar såvitt möjligt hållas friska och sunda.

Jag har emellertid gjort en annan erfarenhet i fråga om dylika läkareundersökningar än den föregående ärade talaren. Det är ju endast mera välsituerade kommuner, som ha råd att hålla sig med dessa läkareundersökningar, och där har det visat sig, att de varit mycket schematiska. En gång i terminen vid inskrivningen ha barnen tågat förbi läkaren, som tittat på dem utan någon närmare undersökning. Något sådant tycker Jag icke har något värde. Man skall därför icke, som motionären här glJorde, med en rad av tabeller över sjukdomsfall

försöka övertyga kammaren om att det här gäller en grundlig undersökning, som kommer att ge folkhälsan ett stort tillskott.

Det har nämnts, att sådana läkareundersökningar ske vid läroverken. Det anfördes också i utskottet av en väl förfaren läroverkslärare, att dessa undersökningar ha mycket litet värde i och för sig. Det tycks mera vara ett till-' fälle för vederbörande läkare att göra sig en viss inkomst.

I den utredning, som gjordes av folkskoleöverstyrelsen, föreslogs, att ersättningen till vederbörande läkare skulle utgå efter tredje klassen av då gällande resereglemente, och att densamma skulle helt och hållet bekostas av statsmedel. Nu måste det väl ändå vara riktigast, att staten icke betalar hela kostnaden, utan att man får uppsätta villkor för statsbidraget, här liksom på andra områden, att kommunen skall tillskjuta en viss del av kostnaden och staten en viss del. Följden blir dock den, enligt vad erfarenheten i andra liknande fall givit vid handen, att endast de välsituerade kommunerna komma att få nytta av bidraget. Det sägs visserligen i utskottets utlåtande, att man skall tänka på de

mindre välsituerade kommunerna, men det är ju helt naturligt, att om något skall göras, kan man icke blott bevilja statsmedel utan vidare, vilka säkerligen komma att gå till betydande summor, utan följden blir att undersökningen måste bliva obligatorisk.

Den ärade motionären citerade här Svenska stadsförbundets yttrande, i vilket man ställde sig mycket välvillig till motionen, och sedan citerade **hon²** även det yttrande, som inkommit från Svenska landskommunernas förbund. Det sistnämnda innehöll emellertid endast, att »på landsbygden är läkarundersökning av skolbarn mindre vanlig», och **hon²** teg med vad som följde efter detta. När det icke kan bli en rättvis fördelning mellan olika behov, så länge som det endast kommer att bli sådana kommuner, som ha råd att själva bekosta dessa läkareundersökningar, som få statsbidrag, är det naturligtvis icke en riktig väg att gå.

Nu har jag icke reserverat mig mot utskottets förslag, men jag förmodar, att då Kungl. Maj:t så nyligen haft ärendet uppe till behandling men icke funnit sig böra göra något åt saken, kan det icke vara behövligt att återigen besluta om en skrivelse, som skall medföra en ny undersökning, vilken kanske leder till samma resultat som förra gången. Jag vill emellertid säga, att om riksdagen beslutar en skrivelse till Kungl. Maj:t bör det i denna skrivelse även ingå vissa skyldigheter för kommunerna, och undersökningarna böra även göras grundligare än vad som i allmänhet sker, så att det hela icke bara resulterar i er parad av skolbarnen förbi läkaren.

Jag har, herr talman, intet yrkande.